Ictère néonatal dans le service de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya (Burkina faso)

Hamidou Savadogo

Savadogo H[1,2], Guira I[1], Sanou S[1], Ouermi AS[1,2], Nagalo K[3,4]

1. Service de Pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire Régional (CHUR) de Ouahigouya, BP 36 Ouahigouya
2. Unité de formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SS), Université Lédéa-Bernard-Ouédraogo, 01 BP 346 Ouahigouya 01
3. Service de Pédiatrie, Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles-de-Gaulle, 01 BP 1198 Ouagadougou 01
4. Unité de formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS), Université Joseph Ki-Zerbo, 01 BP 7021 Ouagadougou 01

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Ictère : symptôme très fréquent en période néonatale
- Maroc : motif d'hospitalisation de 21,3% des nouveau-nés au CHU Mohammed VI en 2017.
- Parfois bénin et transitoire, gravité liée au risque potentiel de neurotoxicité (ictère nucléaire)
- Données rares sur le sujet au Burkina Faso

Objectif

- Contribuer à l'amélioration de la prise en charge de l'ictère du nouveau-né au CHUR-OHG grâce à des données récentes sur la question.

Matériel et méthode(s)

- Cadre de l'étude : unité de néonatologie du service de pédiatrie du CHUR de Ouahigouya au Burkina Faso
- Type et période d'étude : étude rétrospective (1er janvier au 31 décembre 2021)
- Inclusion : nouveau-nés hospitalisés pour ictère ou ictère en cours d'hospitalisation.

Matériel et méthode(s)

- Collecte des données : fiche de collecte, variables sociodémographiques, cliniques, paracliniques et thérapeutiques
- Analyse des données : logiciel Epi-info version 7.2.5.

Résultats

- Au total 1314 nouveau-nés hospitalisés durant la période d'étude
- Parmi lesquels 296 avaient un ictère, soit une fréquence hospitalière de 22,5%.
- Age moyen à l'admission 1,2 ± 5,8 jours (extrêmes de zéro et 15).
- Sexe masculin : 58,8%, sexe féminin : 42,2%, sex-ratio : 1,4.

Résultats

- Terme de la grossesse

Terme grossesse	Effectif (n)	Pourcentage (%)
Prématurés	140	47,3
Nés à terme	154	**52**
Post-terme	2	0,7
Total	296	100

Résultats

- Principaux motifs d'admission

Motif d'admission	Effectif (n)	Pourcentage (%)
Prématurité	117	**39,5**
Détresse respiratoire	63	**21,2**
Ictère	48	16,2
Fièvre	29	9,8
Hypotrophie	26	8,8
Impossibilité de téter	3	1
Macrosomie	2	0,7

Résultats

- Début précoce chez 132 patients (44,6% des cas)
- Ictère franc chez 180 nouveau-nés (60,8% des cas)
- Signes cliniques associés : fièvre (22,9%), pâleur (16,9%), signes neurologiques (6,4%), hépatosplénomégalie (1%)
- Bilirubinémie (moyenne) : 297,3µmol/L
- Bilirubine libre : 97% des cas

Résultats

- Causes : Infection néonatale (54,4%), incompatibilité ABO (1%), résorption d'hématome (1%), indéterminée (6,7%).
- Traitement : photothérapie (57,1%), phénobarbital ± photothérapie (55,4%). Transfusion sanguine (10,1%).

Antibiothérapie : cas d'infection néonatale et cause indéterminée

Résultats

- Devenir des nouveau-nés

- ✓ Durée de séjour hospitalier : 13,8 ± 9 jours avec des extrêmes de 1 et 54 jours
- ✓ Evolution favorable : 87,8% ; ictère nucléaire : 1,3%
- ✓ Taux de mortalité : 9,4%

Conclusion

- Fréquence élevée de l'ictère en période néonatale dans notre contexte
- Infection néonatale : première cause d'ictère
- Nécessité d'un suivi prénatal et post-natal de qualité pour prévenir l'ictère et ses complications.

Merci pour votre attention